当院における RhD 陰性患者の緊急輸血対応４例の検討

◎細野 裕未奈[1)]、浅野 栄太[1)]、日比 由佳[1)]、植村 円香[1)]、大舘 紗那[1)]、佐藤 弦士朗[1)]、中村 信彦[1)]
岐阜大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部[1)]

【はじめに】大量出血時の緊急輸血は、迅速な製剤確保と供給が重要である。特に RhD 陰性患者では、RhD 陰性赤血球製剤の確保に時間を要し、対応に苦慮することがある。今回、当院で経験した RhD 陰性患者に対する緊急輸血対応症例について検討した。

【対象・方法】2015 年から 2025 年までの 10 年間に当院の救急部で緊急輸血対応を行った症例のうち、患者血液型判明後に RhD 陰性赤血球製剤を手配した 4 症例を対象とした。出血原因、血液型検査結果、輸血製剤の使用状況、RhD 陰性赤血球製剤への切替経過を後方視的に検討した。

【結果】4 例の内訳は、外傷 3 例、産婦人科 1 例で、平日日勤帯 2 例、時間外 2 例であった。初回検査で RhD 陰性と判明された症例が 3 例、weakD 症例が 1 例であった。全例で緊急対応として RhD 陽性赤血球製剤の依頼が行われ、2 例では実際に RhD 陽性赤血球製剤が投与されたが、いずれも最終的に RhD 陰性赤血球製剤へ切り替えることができた。初期対応は在庫状況により異なり、同日他患者用に準備されていた RhD 陰性血を活用して速やかに対応できた症例があった一方、手配に時間を要した症例も認めた。weakD 症例では、赤血球は RhD 陰性血へ切り替えたが、FFP は在庫不足のため RhD 陽性製剤を投与した。

【考察】RhD 陰性患者の緊急輸血でも、最終的な RhD 陰性赤血球製剤への切り替えは可能であったが、初期対応では RhD 陽性赤血球製剤の投与や院内在庫の調整を要する場合があった。緊急時の RhD 陰性製剤確保には、院内在庫運用、供給体制、対応手順の整備と情報共有が重要と考えられた。

(輸血・細胞治療部：058-230-7266)